

PSICOPATOLOGÍA I NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Desordenes de ansiedad

Por: Mitchel Araúz

MAESTRÍA PSICOLOGÍA CLÍNICA



Mantener la ansiedad como tu propio enemigo, y que tiene que bajar, disminuir, irse y no suceder es una especie de proceso auto-invalidante.

En lugar de eso, lo que tenemos que aprender a hacer es permitir que tu historia traiga al presente pensamientos, sentimientos y recuerdos, y sostenerlos con atención y autocompasión, y luego centrarte en lo que haces y llevarlos contigo en ese viaje.



STEVEN C. HAYES

¿CUALES SON?

Trastorno de ansiedad por separación

Malestar excesivo recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego.

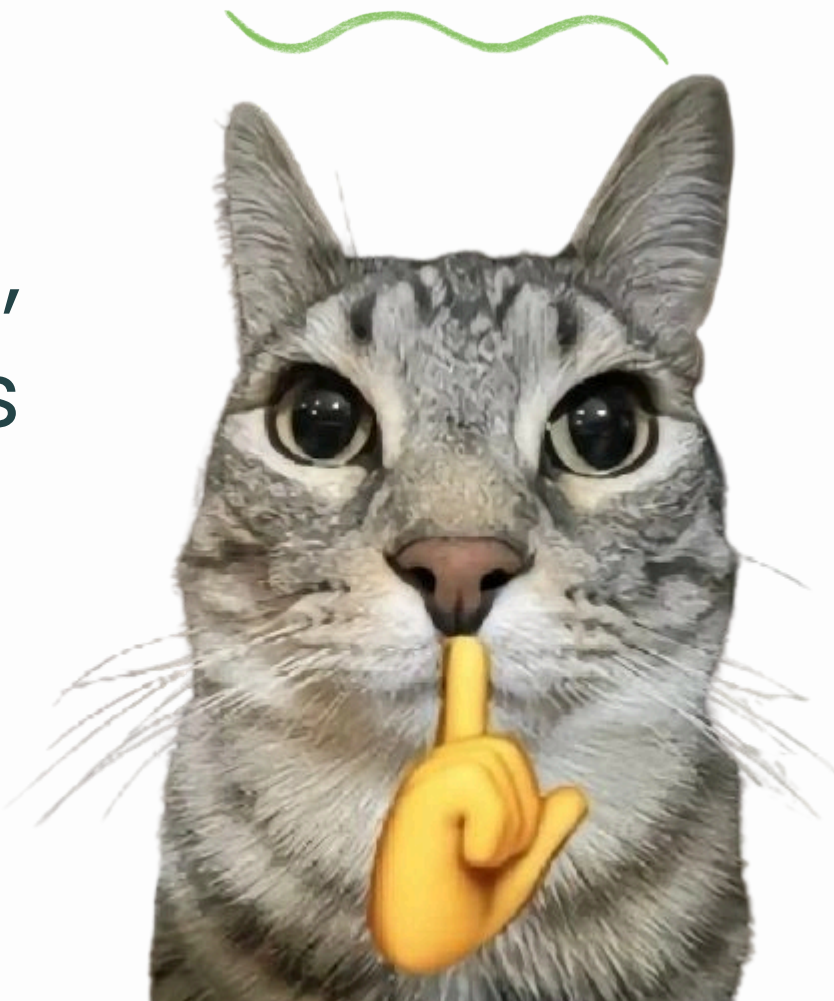


El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 meses o más en adultos.

¿CUALES SON?

Mutismo Selectivo

Fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa de hablar (p. ej., en la escuela), a pesar de hacerlo en otras situaciones.



La duración es de al menos 1 mes (no limitado al primer mes del contexto educativo o otros)

¿CUALES SON?

Fobia Especifica

Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica (p. ej., volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre). Nota: En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o abrazarse.

El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, y dura típicamente 6 meses o más.



¿CUALES SON?

Ansiedad Social

El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente (es decir, que lo humillen o avergüencen; que den lugar al rechazo o que ofendan a otros).

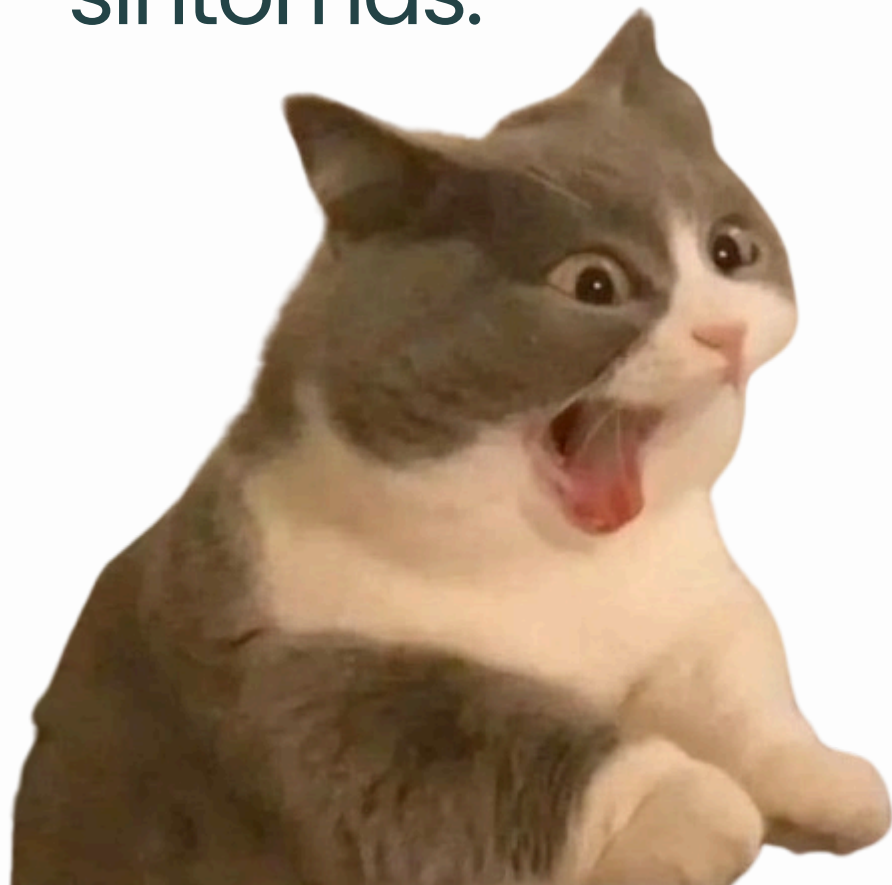
El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 meses o más.



¿CUALES SON?

Trastorno de pánico

Es una aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante el cual se producen cuatro o más síntomas.



Al menos uno de los ataques ha ido seguido de 1 mes (o más) de uno o los dos hechos siguientes:
Inquietud o preocupación continua por otros ataques de pánico o sus consecuencias.

Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques (p. ej., comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico).

¿CUALES SON?

Agorafobia

Miedo o ansiedad
intensa acerca de dos
(o más) de las
siguientes cinco
situaciones:



- ✦ Uso del transporte público (p. ej., automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones).
- ✦ Estar en espacios abiertos (p. ej., aparcamientos, puentes).
O en espacios cerrados.
- ✦ Hacer cola o estar en medio de una multitud.
- ✦ Estar fuera de casa solo.

¿CUALES SON?

Trastorno de ansiedad por otra condición médica

Los ataques de pánico o la ansiedad predominan en el cuadro clínico.

Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que la alteración es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica



¿CUALES SON?

Trastorno de ansiedad generalizada

Ansiedad y preocupación excesiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en el rendimiento escolar o laboral)



¿CUALES SON?

Trastorno de Ansiedad Especificado y No Especificado

Esta categoría se emplea cuando predominan síntomas de ansiedad que causan malestar clínico significativo pero no cumplen los criterios completos de ningún trastorno específico.



Esta codificación se utiliza ante cuadros clínicos donde la ansiedad predomina y genera un deterioro funcional importante en el individuo, pero sin cumplir criterios exactos.

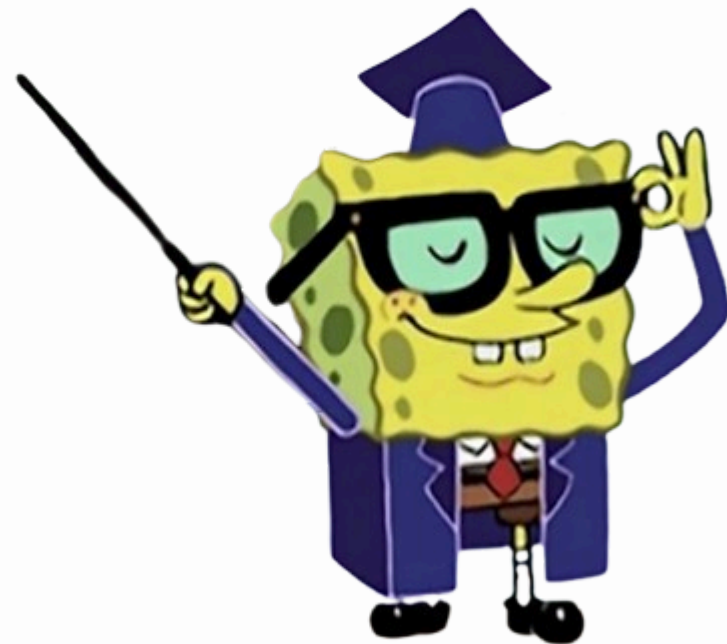
A diferencia de la categoría anterior, aquí el clínico decide no especificar el motivo por el cual no se cumplen los requisitos de un trastorno específico



ESTADÍSTICAS ACTUALES NACIONALES

La mayoría de los residentes en Panamá Metro manifiesta síntomas leves de angustia psicológica, aunque solo una pequeña fracción alcanza niveles críticos de riesgo clínico. Las manifestaciones más comunes no son necesariamente emocionales, sino físicas, destacando las alteraciones en el patrón del sueño y la presencia recurrente de dolores de cabeza.

Esto sugiere que la población tiende a procesar la ansiedad a través de síntomas somáticos antes de identificar un malestar psicológico consciente.

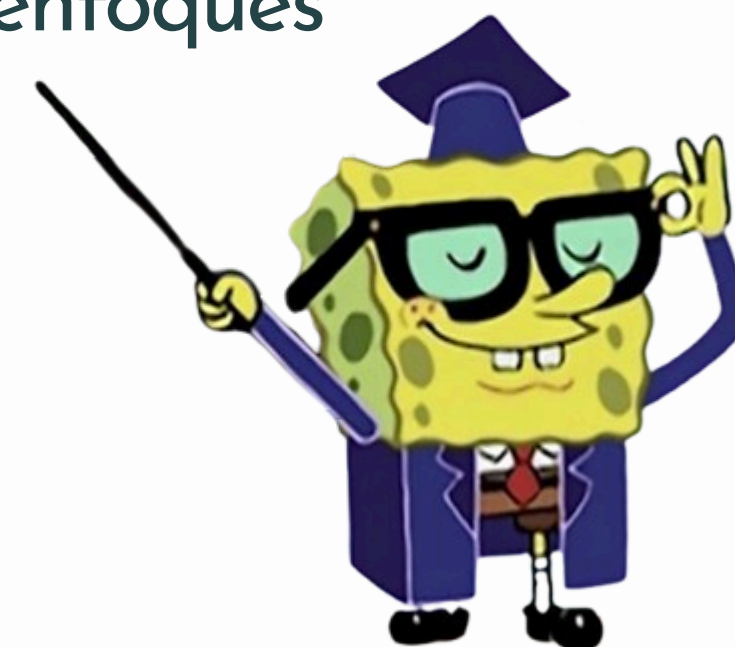




ESTADÍSTICAS ACTUALES NACIONALES



Existe una diferencia notable en cómo se vive la ansiedad según el sexo, siendo las mujeres quienes reportan una mayor carga de síntomas percibidos en comparación con los hombres. Mientras que una proporción significativa de la población masculina refiere una ausencia total de sintomatología, las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad o una mayor apertura para reconocer malestares leves y moderados. Este fenómeno resalta la necesidad de enfoques de atención con perspectiva de género en la región.



ESTADÍSTICAS ACTUALES NACIONALES



El padecimiento de ansiedad en la región se caracteriza principalmente por estados de nerviosismo, tensión y una marcada facilidad para asustarse ante estímulos cotidianos. Curiosamente, el entorno de residencia –ya sea urbano o rural– no parece ser un factor determinante



https://www.gorgas.gob.pa/wp-content/uploads/external/SIGENSPA/documentos/5.%20Factsheet/REGIONALES/ANSIEDAD%20DE PRESION/Hoja%20resumen_Ansiedad_Pma_Metro.pdf



ESTADÍSTICAS ACTUALES INTERNACIONALES



En 2021, 359 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad, lo que los convierte en los más comunes.

Aunque existen tratamientos muy eficaces para este tipo de trastornos, solo una de cada cuatro personas que lo necesitan aproximadamente, reciben algún tratamiento.

Entre los obstáculos a la atención figuran la falta de concienciación de que el problema es una afección de salud que puede tratarse, la falta de inversión en servicios de salud mental, la falta de proveedores de atención de salud capacitados y el estigma social. (OMS, 2023)

CUADRO COMPARATIVO

Trastorno	Diferencia	Similitud
 Ansiedad por Separación	El miedo es la separación física de figuras de apego o el daño que les pueda ocurrir.	Angustia extrema y evitación
 Mutismo Selectivo	Incapacidad consistente para hablar en situaciones sociales específicas donde se espera que se hable, a pesar de poder hacerlo en casa.	Ansiedad social elevada y evitación del habla.
 Fobia Especifica	La ansiedad se limita estrictamente a objetos o situaciones concretas (animales, sangre, alturas)	Activación del sistema nervioso ante un estímulo.
 Ansiedad Social	El foco es el miedo al escrutinio negativo, a la humillación o al rechazo en situaciones de interacción social.	Temor al juicio y síntomas autonómicos.
 Trastorno de pánico	Presencia de ataques de pánico inesperados y recurrentes que no están limitados a un solo estímulo.	Respuesta física intensa (taquicardia, falta de aire).

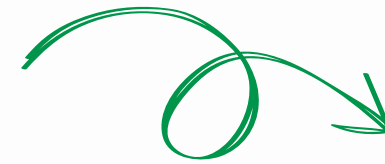
CUADRO COMPARATIVO

Trastorno	Diferencia	Similitud
 Agorafobia	Miedo marcado a lugares o situaciones donde escapar sería difícil o no habría ayuda disponible en caso de malestar.	Evitación conductual para reducir el miedo.
 Ansiedad Generalizada	Preocupación excesiva, persistente y "flotante" sobre múltiples eventos de la vida diaria.	Estado de alerta constante y tensión muscular.
 Debido a condición médica	La ansiedad es la consecuencia fisiopatológica directa de otra condición de salud (ej. hipertiroidismo).	Manifestaciones clínicas de ansiedad.
 Especificado / No Especificado	Se usa cuando los síntomas causan malestar pero no cumplen el perfil completo de una categoría específica (ej. Ansiedad por enfermedad).	Cumplen con la definición general de trastorno de ansiedad.

ARTICULO SOBRE ANSIEDAD

* Epidemiología de la ansiedad y su contexto en atención primaria

La ansiedad es una emoción que ha acompañado a la humanidad durante toda su historia; ha sido motor de cambio y supervivencia, pero cuando aparece de forma desproporcionada o bien ante estímulos erróneos, es cuando estamos ante un trastorno de ansiedad.



<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S260507302400004X>





Emma Stone



Kristen Stewart



Selena Gómez



Johnny Deep



Gracias por su atención

